

ÉTUDE POLYGRAPHIQUE DU SOMMEIL

Rapport d'Analyse Respiratoire et Oxymétrique

Dr. Selma BAKHA

Pneumologue - Allergologue

N° Ordre : 0535/24

☎ 0663 755 584

📍 Cité 19 Juin, derrière l'hôpital Hakim Okbi
en face des urgences, Guelma

✉ selma.bakha@hotmail.com

INFORMATIONS DU PATIENT

Nom :	ARAB FATIMA	ID Patient :	20260922-137
Genre :	Féminin	Période enreg. :	00 :09–09 :09
Âge :	71 ans	Durée totale :	525,0 min (8h 45min)
Taille / Poids :	157 cm / 63 kg	Durée valide :	525,0 min (100,0%)
IMC :	25,6 kg/m ²	Date d'examen :	22 Septembre 2026
Comorbidités :	Insuffisance Rénale Chronique Terminale (IRCT, Stade 5) – HTA		



Scanner pour accéder au tracé complet et dossier numérique

1. GRAPHIQUE DE TENDANCE POLYGRAPHIQUE



FIGURE 1 – **Enregistrement continu multicanal (00 :09–09 :09)** : Variations oxymétriques (SpO_2), flux respiratoire, fréquence du pouls, position corporelle et identification des événements hypopnéiques prédominant en décubitus dorsal.

2. ANALYSE DES ÉVÉNEMENTS DU SOMMEIL

Source : rapport natif de l'appareil (*Sleep Monitoring Report, Breath Information Summary, SpO2 Summary*).

2.1. DISTRIBUTION POSTURALE ET IMPACT VENTILATOIRE

TABLE 1 – Événements respiratoires et désaturations selon la position corporelle

Position	Durée (min)	%	HYPO	SAOS	AC	AM	DO	IDO (/h)	Total Resp.
Dorsale (SUP)	520,7	99,2%	105	0	0	0	288	33,2	105
Ventrale (PRO)	0,0	0,0%	0	0	0	0	0	—	0
Côté gauche (LAT-G)	0,1	0,0%	0	0	0	0	0	—	0
Côté droit (LAT-D)	3,3	0,6%	0	0	0	0	4	73,5*	0
Érigée / Debout (STAND)	0,9	0,2%	0	0	0	0	0	—	0
Total / Moyenne	525,0	100%	105	0	0	0	292	36,5**	105

2.2. CINÉTIQUE DE L'OXYMÉTRIE DE POULS (SpO₂)

TABLE 2 – Paramètres oxymétriques détaillés et cinétique du signal

Paramètre Oxymétrique	Valeur	Norme /
SpO ₂ maximale (%)	98	
SpO ₂ minimale (Nadir oxymétrique ponctuel)	84	
SpO ₂ moyenne (%)	91	
Durée cumulée des désaturations relatives (min)	236,7	45,1 % du total
Durée moyenne d'une désaturation	48,6 s	
Durée maximale d'une désaturation	118,0 s	
Nombre total d'événements de désaturation (DO)	292	
Index de Désaturation en Oxygène (IDO global)	36,5 /h	
Index de Désaturation en Décubitus Dorsal	33,2 /h	
Temps passé sous 95% de SpO ₂ (min)	507,3	96,7 % du total
Temps sous 90% de SpO ₂ (T90 en min)	106,9	20,4 % (Hypoxénie)
Temps passé sous 85% de SpO ₂ (min)	0,2	< 0,1 % du total
Temps passé sous 80% de SpO ₂ (min)	0,0	0,0 % du total
Charge Hypoxique (Hypoxic Burden, méthode Azarbarzin)[†]	30,13 %-min/h	Risque CV élevé si > 19-20 %-min/h

2.3. ANALYSE DES ÉVÉNEMENTS RESPIRATOIRES (APNÉES & HYPOPNÉES)

TABLE 3 – **Caractérisation et indexation ventilatoire**

Catégorie Événementielle	Nombre	Index (/h)
Apnées (Total : 0)		
Apnées Obstructives (SAOS)	0	
Apnées Centrales (AC)	0	
Apnées Mixtes (AM)	0	
Durée cumulée des apnées	0,0 min	(0,0% du temps total)
Durée moyenne / Durée maximale	—	—
Hypopnées (Total : 105)		
Nombre total d'hypopnées	105	12,0
Durée cumulée des hypopnées	41,7 min	(7,9% du temps total)
Durée moyenne / Durée maximale	23,8 s	64,2 s
Synthèse Ventilatoire Globale		
Nombre cumulé d'événements respiratoires	105	—
Durée totale cumulée sous événement (min)	41,7 min	7,9 % de l'enregistrement
Durée moyenne d'un événement respiratoire	23,8 s	—
Indice d'Apnées-Hypopnées (IAH)	—	12,0 /h
Index de Désaturation en Oxygène (IDO)	—	36,5 /h
Respiratory Disturbance Index (RDI)*	—	12,0 /h

3. TABLEAU DE BORD SYNTHÉTIQUE

TABLE 4 – Récapitulatif des biomarqueurs polygraphiques et cardiovasculaires

Indicateur	Valeur	Indicateur	Valeur
SpO ₂ moyenne (%)	91 %	SpO ₂ minimale (%)	84 %
IDO global (/h)	36,5	IDO dorsal (/h)	33,2
Charge Hypoxique[†] (%·min/h)	30,13	Temps sous 90% (T90)	20,4 %
Temps total d'enregistrement	525,0 min (8h 45)	RDI (/h)	12,0
Index d'Apnées (IA /h)	0,0	Nombre d'Hypopnées	105 (IH : 12,0/h)
IAH global (/h)	12,0	Changements de position	283
Fréquence cardiaque moyenne	61,5 bpm	FC min / FC max (bpm)	56 / 71
IMC (kg/m ²)	25,6	Durée max Désaturation (s)	118,0

4. AVIS MÉDICAL ET CONDUITE À TENIR

1. Synthèse polygraphique

- **Événements respiratoires** : présence d'un **index d'apnées-hypopnées (IAH) à 12,0/h**, avec **105 hypopnées** et aucune apnée obstructive, centrale ou mixte détectée. Ce résultat est compatible avec un **trouble respiratoire du sommeil d'intensité légère**.
- **Retentissement oxymétrique important** : profil d'hypoxémie nocturne marqué avec une **SpO₂ moyenne à 91 %**, un **nadir à 84 %**, un **IDO à 36,5/h**, un **T90 à 20,4 %** (106,9 min) et une **charge hypoxique élevée à 30,13 %·min/h**. Ces anomalies justifient une interprétation clinique approfondie.
- **Discordance entre l'IAH et le retentissement oxymétrique** : l'importance des désaturations apparaît disproportionnée par rapport au nombre d'événements respiratoires détectés. Cette discordance justifie la recherche d'une cause associée d'hypoxémie nocturne, notamment une éventuelle hypoventilation, une atteinte cardiopulmonaire ou une contribution du statut volémique dans le contexte d'IRCT stade 5.

2. Conclusion diagnostique

- **Trouble respiratoire du sommeil à prédominance hypopnéique, d'intensité légère** (IAH = 12,0/h), sans apnée obstructive, centrale ou mixte détectée au cours de cet enregistrement.
- **Hypoxémie nocturne significative** avec désaturations fréquentes et prolongées : IDO = 36,5/h, T90 = 20,4 %, SpO₂ moyenne = 91 % et nadir à 84 %.
- Compte tenu de la **discordance entre l'IAH et l'importance du retentissement oxymétrique**, une cause associée d'hypoxémie nocturne doit être recherchée, particulièrement dans le contexte d'**IRCT stade 5 et d'HTA**.

3. Conduite à tenir proposée

1. **Avis néphrologique prioritaire** : réévaluation du **statut volémique**, notamment du poids sec et des paramètres d'épuration selon le contexte clinique. Toute adaptation de l'ultrafiltration relève de l'équipe néphrologique.